

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Eva de las Nieves Rodríguez, Gema M^a Gómez García, M^a Fátima Fernández Salgado

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual siguen un continuo crecimiento tanto en España como en Europa desde el siglo XXI, parece que debido a la falta de información/concienciación entre adolescentes y adultos jóvenes. La ausencia de un diagnóstico y tratamiento precoz, conlleva graves complicaciones y secuelas.

La evaluación inicial debe incluir:

- Anamnesis detallada: comportamiento sexual de riesgo, parejas y género en los 90 días previos, viajes (turismo sexual), otros síntomas acompañantes, historia previa de ETS, uso de drogas.
- Examen físico: local y general
- Pruebas diagnósticas: necesarias por la variabilidad de síntomas en las ETS desde floridas a asintomáticas, o por la presentación, a veces atípica, de las mismas.
- Tratamiento empírico: puesto que la mayoría de las pruebas diagnósticas tardarán varios días en ofrecer sus resultados, y otras, más rápidas y de elevado coste, no están disponibles en los servicios de Urgencias. Abordar la/s pareja/s sexual/es si fuese posible y canalizar al paciente en el despistaje de otras ETS, dado que en múltiples ocasiones concurren juntas.
- Asesoramiento sobre los test a realizar y el uso aconsejado de condón, y asegurar la siguiente visita en la primera semana tras el inicio del tratamiento para evaluar la respuesta clínica y revisar los resultados de las pruebas diagnósticas practicadas.

Recordemos que son Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) la Sífilis, la Infección Gonocócica, el Linfogranuloma venéreo y el VIH/SIDA.

1. URETRITIS-CERVICITIS-PROCTITIS

Introducción:

La Chlamydia trachomatis es la causa bacteriana más frecuente de enfermedad de transmisión sexual (serotipos D-K), seguida de Neisseria gonorrhoeae. Existe infección simultánea en el 30% de los casos. Otros agentes causales son U. Urealyticum y M. genitalium. Pueden provocar infecciones urogenitales o anorectales (proctitis tras relación sexual anal receptiva, considerar además como agentes causales VHS y sífilis que se exponen más adelante en este capítulo).

Diagnóstico:

Clínica

Síntomas de uretritis: disuria y secreción uretral unos 3-5 días tras contacto sexual en gonocócica y 1-2 semanas en no gonocócica.

Síntomas cervicitis: exudado endocervical purulento o sangrado endocervical al roce, aunque suele ser asintomática y constituye el reservorio.

Síntomas proctitis: tenesmo rectal, sangrado o mucosidad rectal, dolor anorectal que empeora al defecar, estreñimiento, plenitud rectal (pueden ser asintomáticos)

Diagnóstico sindrómico

*Secreción uretral mucoide o purulenta más uno de los siguientes:

- Gram secreción uretral con >5 leucos/campo (si se observan diplococos gramnegativos en el interior de los neutrófilos se trata de uretritis gonocócica)
- Primer chorro orina con estearasa leucocitaria + ó >5 leucos/campo

*Exudado endocervical purulento más >10 leucos/campo en fluido vaginal.

Diagnóstico etiológico

La realización de PCR es la más sensible y específica para N. gonorrhoeae y C. trachomatis en el primer chorro de la orina en el varón (no es necesario el frotis uretral) y en frotis endocervical en la mujer. Se recogerán hisopos faríngeos o rectales si existe historia de sexo oral/anal sin protección. Para el gonococo también se utiliza el cultivo de Thayer-Martin que permite realizar antibiograma.

Tratamiento:

Debe iniciarse en el momento de la primera visita, así fuese sólo un diagnóstico sindrómico. Se deben tratar ambos agentes debido al alto índice de coinfección. Los objetivos son prevenir complicaciones, disminuir el riesgo de transmisión y resolución de síntomas.

*De elección: Ceftriaxona 500 mg im dosis única + Doxiciclina 100 mg c/12horas x 7 días (preferible Azitromicina 1 gr en dosis única en embarazadas)

*No disponible im: Cefixima 800 mg vo + Azitromicina 1 gr vo (ambas dosis única)

*Alérgicos a penicilinas: Gentamicina 240 mg im + Azitromicina 2 gr vo (ambas dosis única).

Complicaciones:

- **Orquiepididimitis:** epidídimo engrosado y doloroso
- **Enfermedad inflamatoria pélvica:** dolor pélvico o abdominal, sangrado vaginal anormal, dispareunia incluso fiebre.
- **Perihepatitis (síndrome Fitz-Hugh-Curtis) en mujeres:** dolor en HCD, náuseas, vómitos y fiebre debidos a la inflamación de la cápsula de Glisson asociado a enfermedad inflamatoria pélvica. Función hepática normal o levemente elevada en los análisis.
- **Infección gonocócica diseminada:** bacteriemia que sucede en el 0'5-3% de los infectados. Existen dos cuadros clínicos: artritis purulenta o la triada de tenosinovitis, dermatitis y poliartralgias. Resultan raras la endocarditis, meningitis u osteomielitis.
- **Artritis reactiva:** sólo o asociada a la triada artritis + conjuntivitis/uveítis + uretritis/cervicitis (frecuentemente asociado a *C. trachomatis*)
- **Conjuntivitis:** principalmente afecta a recién nacidos de madres no tratadas, aunque se han descrito casos en adultos y adolescentes por autoinoculación; también existen casos de transmisión por fómites o moscas.
- Ruptura prematura de membranas en mujer gestante

Consejo y seguimiento:

Se aconsejará a los pacientes abstinencia sexual hasta una semana después de haberse iniciado el tratamiento. Todas las parejas sexuales de los 60 días previos al diagnóstico han de ser evaluadas y/o tratadas (especialmente mujeres asintomáticas).

A toda mujer en edad fértil que acude con infección urogenital, se le practicará un test de embarazo.

Se debe comprobar la curación mediante cultivo, a los tres meses del tratamiento, a todo individuo diagnosticado de infección gonocócica urogenital o anorrectal (en especial en mujeres embarazadas) para evaluar reinfección.

2. ÚLCERAS GENITALES

Las enfermedades de transmisión sexual son la causa más frecuente de úlceras genitales, siendo las más prevalentes en España el herpes (HSV 1 y 2) y la sífilis (*Treponem pallidum*). Desde 2005, se vienen detectando brotes de linfogranuloma venéreo (LGV) en hombres que tenían relaciones sexuales con hombres (HSH). Aunque la anamnesis y exploración física darán importantes pistas sobre el diagnóstico, permitiendo en muchos casos el inicio de un tratamiento empírico, se deben recoger las muestras adecuadas para su análisis y confirmación etiológica. En cualquier caso, siempre se realizará la prueba de HSV (si no se dispone de confirmación microbiológica en brote previo) y sífilis, y se derivará para despistaje de VIH, gonococo y chlamydia. A pesar de ello, el 25% de las úlceras genitales, quedarán sin diagnóstico confirmado por laboratorio.

El tratamiento empírico se iniciará ante la exposición a una ETS conocida, úlceras genitales sugestivas de infección por virus herpes simple o sífilis, o en una situación de brote detectado de linfogranuloma venéreo. También se administraría medicación ante lesión sugestiva de cancroide si sospechamos que el paciente no realizará seguimiento posterior. Hay que tener en cuenta, que la presencia de úlceras genitales es un factor de riesgo para la transmisión del VIH.

También recibirán tratamiento, aún asintomáticos, los contactos de pacientes con sífilis primaria, cancroide o linfogranuloma venéreo.

2.1 SÍFILIS

Introducción

ETS causada por la espiroqueta *T. pallidum*. Presenta periodo de incubación de 2-6 semanas.

Vía de inoculación es a través de lesiones en mucosa o piel durante las relaciones sexuales. Las vías congénitas, fómites y transfusiones son excepcionales.

Es frecuente su coinfección con VIH.

Presenta distintas manifestaciones clínicas en función de estadio. Dividiéndose en

Sífilis Temprana : 1º año desde la infección, que su vez se divide en Sífilis primaria y secundaria.

Sífilis Tardía o Terciaria.

Clínica:

Sífilis Primaria: aparece lesión cutánea papulosa de 1-2 cm que se ulcera, presentando bordes sobre-elevados indurados en la zona de inoculación, generalmente indolora --) **Chancro duro**. El periodo de incubación varía entre 3 a 90 días, siendo la media 21 días. Asociando adenopatías induradas en zona proximal, habitualmente bilaterales e indoloras. En pacientes VIH suelen ser múltiples chancros.

Desaparece de forma espontánea, incluso sin tratamiento en 3-6 semanas, por lo que muchos pacientes no consultan.

Sífilis Secundaria: en un 25% de pacientes no tratados durante la sífilis primaria, se produce una diseminación sistémica de la espiroqueta, habitualmente a las 2-6 semanas tras la desaparición del chancro se inicia clínica de sífilis secundaria.

- **Síntomas Constitucionales:** Fiebre, cefalea, anorexia, pérdida de peso, faringodinia...
- **Adenopatías:** Habitualmente en región cervical, axilar inguinal y femoral, de consistencia gomosa simétricas. Cuando aparecen en región epitroclear son prácticamente diagnósticas de Sífilis
- **Dermatológicas:**
 - **Rash** sobretodo maculopapular de color rojizo o marronáceo, simétricas en tronco, extremidades y en palmas y plantas (clavos sifilíticos, muy dolorosos) de 0.5 a 2 cm de diámetro. Escamosas, en alguna ocasión nodular
 - **Pústulas.**
 - **Lesiones mucosas:** Parches Mucosos: erosiones en mucosa oral o lengua. Pápulas partidas en comisura bucal. Condiloma lata: lesiones alargadas, de color gris-blanquecino en zonas húmedas (boca, periné... zonas próximas a lesión 1º), muy contagiosas por tener todas numerosas espiroquetas
 - **Alopecia:** lesiones caída de pelo en cuero cabelludo, barba y cejas, de aspecto "apolillado", se resuelven con tratamiento de sífilis.
- **Alopecia:** lesiones caída de pelo en cuero cabelludo, barba y cejas, de aspecto "apolillado", se resuelven con tratamiento de sífilis.
- **Afectación gastrointestinal:**
 - Hepatitis sifilítica: Aumento de pA, transaminasas normales, cura con tto sífilis.
 - Infiltrado o ulceración extensa que puede confundirse con linfoma
- **Lesiones musculoesqueléticas:** sinovitis, periostitis...
- **Afectación renal:** síndrome nefrótico, HTA, Fallo renal, GNmembranosa, mejora con tto
- **Afectación neurológica y ocular:** aparece en sífilis temprana: Cefalea, meningitis, afectación meningovascular, ICTUS, uveítis anterior y posterior, coriorretinitis, necrosis retiniana, neuritis, muy importante el diagnóstico rápido de sífilis ante esta sintomatología.

Sífilis Tercaria o tardía: entre el 25-40% de los pacientes no tratados durante la sífilis temprana desarrollan las secuelas de este periodo. Puede aparecer desde pasado el 1º año de contagio hasta 30 años después. Las manifestaciones más frecuentes son:

- **Cardiovasculares:** aortitis: dilatación de la Aorta con Insuficiencia válvula aórtica, se ausculta 2º tono agudo. Aparece a los 15-30 años de la primoinfección.
- **Sífilis Gomosa:** granulomas y nódulos sobretodo en piel y huesos.
- **Neurosífilis:** afectación del SNC paresia y Tabes dorsal

En esta fase de la enfermedad es necesario demostrar la existencia de *Treponema pallidum* en las lesiones, principalmente de la clínica neurológica.

Sífilis Latente: asintomática.

Diagnóstico:

Ante una clínica compatible en paciente con relaciones sexuales de riesgo se deben realizar pruebas de laboratorio, que pueden ser directas o indirectas.

- **Directas:**
 - Microscopio de campo oscuro: visualización del T. pallidum en fluído analizado.
 - PCR T. pallidum
- **Indirectas:**
 - Serología (Diagnóstico más usado)
 - Pruebas No Treponémicas: RPR y VDRL
 - Pruebas Treponémicas : FTA-ABS, TPHA y MHA-TP
- **Diagnóstico de Neurosífilis:**
 - Análisis de LCR
 - Signos o síntomas de SNC o/y oculares.
 - Título de RPR o VDRL > 1:32
 - VIH con CD4 < 350
 - Sospecha ante fracaso terapéutico.

Tratamiento:

Hay que incluir a los contactos de 90 días previos a la clínica, aunque la serología sea negativa. Incluso a mujeres embarazadas y VIH

- **Sífilis Primaria y Secundaria o Latente Temprana:** Penicilina G 2.4mill i.m dosis única o Doxiciclina 100/12h 2 semanas
- **Sífilis Latente Tardía o indeterminada:** Penicilina G 2.4 mill im 1/semana 3 semanas, o Doxiciclina 100/12h 4 semanas
- **Neurosífilis:** Penicilina G 3-4 mill iv /4h 10-14 días o Ceftriaxona 2g iv/24h 10-14 días.

Tras la 1º dosis de Penicilina puede aparecer la reacción de JARISH-HERXHEIMER que consiste en fiebre, escalofríos, mialgias , cefalea, taquicardia , leucocitosis, vasodilatación con hipotensión que cede espontáneamente en 12-24h

Tras el tratamiento debe hacerse seguimiento serológico por su Médico de Enfermedades infecciosas.

2.2 VIRUS HERPES SIMPLE (VHS)

Introducción

Tanto VHS-1 como VHS-2 (más prevalente con el 80%) provocan infección genital y recurrencias. El contagio se produce por contacto directo de piel erosionada o dañada (oral-genital-anal) con las lesiones herpéticas, derivando en la primoinfección (tras periodo incubación de 2-12 días).

Síntomas (hasta 70% cursan asintomáticos): iniciales con quemazón, prurito, edema y eritema; aparición de vesículas umbilicadas, pequeñas y dolorosas que pueden confluir en úlceras de mayor tamaño y bordes festoneados. A veces se acompañan de adenopatías pequeñas y dolorosas. Puede cursar con disuria y exudado uretral/vaginal. Incluso presentar síntomas generales, sobre todo en la primoinfección, como fiebre, cefalea, malestar general y mialgias.

Duración: el episodio puede durar 3 semanas (10 días en recurrencias).

Complicaciones: se han descrito meningitis aséptica, radiculitis lumbosacra en “silla de montar” con mielitis, dificultades en la micción/defecación (episodios de retención aguda de orina).

Recurrencias: se desencadenan en situaciones de inmunosupresión, estados de estrés, durante la menstruación en mujeres o en el curso de otra infección. El agente causal más frecuente es el VHS-2. La presentación clínica suele ser de similar localización e intensidad a la primoinfección.

Diagnóstico:

Toma de muestra con torunda del exudado y fondo de la lesión (en medio viral) para PCR específica (o muestra del LCR). Los cultivos tienen sólo una sensibilidad del 50%.

Tratamiento:

Disminuye la duración, gravedad, desarrollo de complicaciones, riesgo de recurrencias y de transmisión a pareja sexual. Aciclovir iv se reserva para los casos de infección complicada.

Primer episodio	• Aciclovir 400mg VO c/8 horas x 7 -10 días ó • Fanciclovir 250mg VO c/8 horas x 7 -10 días ó • Valaciclovir 1000mg VO c/12 horas x 7 -10 días
Episodio recurrente	• Aciclovir 800mg VO c/8 horas x 2 días ó • Fanciclovir 1000mg VO c/12 horas un único día ó • Valaciclovir 500mg VO c/12 horas x 3 días
Terapia supresiva (si 6 ó más recurrencias al año)	• Aciclovir 400mg VO c/12 horas x 6 -12 días ó • Fanciclovir 250mg VO c/12 horas x 6 -12 días ó • Valaciclovir 1000mg VO c/24 horas x 6 -12 días

Tras la resolución de la primoinfección del virus herpes simple, puede existir secreción viral intermitente y asintomática incluso en ausencia de lesiones.

2.3 CHANCROIDEIntroducción

ETS infrecuente en Europa y en países desarrollados. Causada por *Haemophilus ducreyi*

Es típica de América del Sur, Caribe, India, África y sudeste asiático, de hecho su transmisión es por relación sexual con personas de estos países.

Clínica

Tiene un período de incubación de aproximadamente 4-10 días, apareciendo una pápula que rápidamente se convierte en pústula que se ulcera en zona central, blanda al tacto, de 1-2 cm. Puede ser única o múltiples.

Asocia frecuentemente adenopatía loco-regional dolorosa (más frecuente en hombres que en mujeres) que drena material purulento en los días siguientes a su aparición.

Diagnóstico

- Cultivo
- Gram del aspirado purulento de la adenopatía.
- PCR

Tratamiento

- Azitromicina 1g una dosis
- También puede usarse:
 - Ciprofloxacino 500 1/12h 3 días
 - Ceftriaxona 250 im unidosis
 - Eritromicina 500/8h vo 7 días

2.4 LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV)Introducción

Producido por los serotipos L1, L2, y L3 de *Chlamydia trachomatis* con capacidad de invadir y reproducirse en los ganglios linfáticos locales. Endémico de ciertas zonas de África, India, el sudeste asiático, América del Sur y el Caribe. En occidente cada vez se reportan más casos en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que suelen cursar con proctitis más que con úlcera genital y linfadenopatías. La mayoría de los HSH que adquieren esta enfermedad, están además infectados por VIH, lo que supone mayor riesgo de transmisión.

La sintomatología se desarrolla en 3 fases:

- **Primera:** periodo de incubación 3-12 días; después, en el sitio de inoculación se produce una pequeña úlcera vs inflamación de la mucosa que se resuelve en pocos días de forma espontánea.
- **Segunda:** 2-6 semanas después, por extensión directa a los ganglios regionales inguinales/femorales. En los hombres se produce una gran inflamación profunda de ganglios inguinales, uni o bilateral, que coalescen formando grandes masas dolorosas llamadas bubones que pueden romperse. En la mujer esta reacción suele

suceder en los ganglios linfáticos perirrectales y pelvianos más profundos.

La infección anorrectal suele acompañarse de fiebre, malestar, tenesmo y sangrado/secreción rectal o dolor anal, desarrollando trayectos fistulosos o estenosis.

- **Tercera:** se generan cicatrices y trayectos fistulosos que pueden persistir o recidivar sobre todo en pacientes no tratados. La inflamación persistente de los ganglios en la infección no tratada puede provocar de forma tardía edema/elefantiasis genital, pelvis congelada, infertilidad y en casos extremos, destrucción generalizada de los genitales externos (más en mujeres).

Diagnóstico:

Realización de PCR en las diferentes muestras (según localización). La PCR que diferencia los serotipos de *C. trachomatis* no está siempre disponible y, además, tarda semanas en ofrecer el resultado. La serología puede ser útil en dos circunstancias: en tercer estadio si no existen secreciones de donde recoger la muestra o cuando el paciente ha sido tratado para *Chlamydia* de forma empírica y se precisa confirmar el diagnóstico de forma retrospectiva

Tratamiento:

En todos los pacientes incluso asintomáticos.

- ***De elección:**
 - Doxiciclina 100 mg vo c/12 horas x 3 semanas. (Si la presentación clínica es de proctocolitis, se añade Ceftriaxona 250 mg im dosis única)
- ***Alternativo:**
 - Azitromicina 1 gr vo una vez a la semana x 3 semanas.
- ***Mujeres embarazadas y lactantes:**
 - Eritromicina 500 mg vo c/6 horas x 3 semanas.

El paciente requiere seguimiento posterior durante 6 meses. Inicialmente para evaluar la respuesta al tratamiento que debe ser casi completa a los 21 días.

Se aconseja abstinencia sexual hasta que los síntomas se hayan resuelto y se haya completado el tratamiento, incluso el de su/s pareja/s sexual/es.

Todas las parejas sexuales de los 60 días previos al inicio de síntomas o diagnóstico deben ser tratadas:

- ***Asintomáticos:**
 - Azitromicina 1 gr vo dosis única ó
 - Doxiciclina 100 mg vo c/12 horas x 7 días (si los test confirman el diagnóstico se completará el régimen hasta las 3 semanas).
- ***Sintomáticos:** mismo tratamiento que el del paciente en espera del resultado de los test.

2.5 GRANULOMA INGUINAL O “DONOVANOSIS”

Introducción:

Se trata de una infección rara, causada por *Klebsiella granulomatis*, endémica de zonas como Papua Nueva Guinea, Australia, el sur de África, el Caribe y ciertas áreas de Brasil e India.

Clínica: tras un periodo de incubación de 1-12 semanas, aparece un nódulo cutáneo eritematoso, indoloro, de olor desagradable, que posteriormente se ulcera y se va extendiendo a otras áreas de la piel. Las lesiones, que pueden aparecer en región urogenital, anla/glútea incluso en la cara, curan y dejan cicatrices

Diagnóstico:

Examen microscópico que muestra los cuerpos de Donovan en el líquido obtenido de una lesión.

Tratamiento:

*De elección: Azitromicina 1 gr/semanal vo (ó 500 mg diarios) durante al menos 3 semanas o hasta que las lesiones se hayan curado por completo.

*Alternativo: Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas ó Eritromicina 500 mg vo cada 6 horas ó TMP/SMX 160/800 mg vo cada 12 horas.

Consejo y seguimiento:

Hay que observar la respuesta al tratamiento en los 7 días siguientes al inicio. A pesar de adecuada evolución, el paciente debe controlarse durante 6 meses.

Las parejas sexuales de los 60 días previos al inicio de los síntomas del caso, deben ser evaluadas y recibir tratamiento en caso de diagnóstico positivo, a pesar de encontrarse asintomáticas.

2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ITS ULCEROSAS

	VHS	Chancroide	Sífilis	LGV	Granuloma inguinal
Dolorosa	+	+	-	-	-
Número	múltiples	múltiples	única	única	una o varias
Características	Vesículas agrupadas sobre base eritematosa	Profundas, irregulares, base amarillo-grisácea y borde violáceo excavado	Indurada y bien circunscrita	Poco profunda	Nódulos friables, se ulceran, bordes sobrelevados Lesiones "en beso"
Adenopatías inguinales	+ blandas	+ blandas y/o supuradas	+ gomosas (sífilis primaria tardía)	+ bandas y/o supuradas	-
Síntomas constitucionales	+ Fiebre, malestar, mialgias	-	+ cefalea, fiebre, malestar (sífilis secundaria)	+ fiebre, malestar, lumbalgia, dolor pélvico (2º estado)	-
Recurrencias	+	-	-	+ 3er estado	-
Meningitis aséptica/retención urinaria	+	-	-	-	-

3.- CONDILOMAS ACUMINADOS Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VHP)Introducción:

Producidos por VPH: Es la ETS más prevalente. Su importancia radica en su alta relación con aparición de lesiones precancerosas y cancerosas. Está presente en la menos 10% de la población. Afectando sobre todo al cérvix y al canal anal. Es altamente contagioso, la transmisión es por contacto con mucosa o piel infectada y presencia de microabrasiones, también se transmite por fómites y pudiendo un paciente autoinocularse.

Existe un elevado número de serotipos

- Los serotipos: 16, 18, 31, 33 y 35 son los de mayor riesgo de cáncer (genital y de cabeza y cuello).
- Los serotipos: 6, 11 y 42 producen condilomas acuminados

Hay factores de riesgo: como el tabaco, la actividad sexual, relaciones anales.

Diagnóstico:

Clínica: Condilomas acuminados o verrugas anogenitales: aparecen sobretodo en vulva, pene, ingle, periné, piel anal

Presentan múltiples formas: planos, filiformes, coliformes, pedunculados, como placas...

Su coloración puede variar: blanco, color de la misma piel, rojizo, marrónáceo, hiperpigmentación...

Suaves y blandos a la palpación, de 1mm a varios cm de diámetro

Aunque habitualmente son asintomáticos pueden producir prurito, en caso de estar en cérvix o uretra producen coitorragia en ocasiones, sangrado uretra. Deformidad en región anogenital, produciendo molestias en la defecación cuando son de gran tamaño.

Rara vez malignizan..

Cribado:

- Biopsia
- Citología y Técnica de Papanicolau

Tratamiento:

- Cirugía
- Criocoagulación
- Conización laser C02
- Imiquimod crema 5%

Importancia prevención: métodos barrera y Vacunación

4. PEDICULOSIS PUBIS

Introducción

Pediculosis del pubis es habitualmente causada por *Phthirus pubis*, transmitida por relaciones sexuales que afecta principalmente a la zona púbica pero puede extenderse por otras partes del cuerpo, incluidas las pestañas. *P. pubis* es un parásito translúcido de 0,8 a 1,2 mm de largo. 3 de sus 6 patas terminan en una especie de pinza de cangrejo que le ayuda a agarrarse al vello. El ciclo de vida de la hembra es de unas 3-4 semanas de vida en las que pone 3 huevos/día que eclosionan en 6-8 días.

La transmisión es generalmente durante la relación sexual pero puede contagiarse por fómites, ropa, toallas.... Cuando aparecen en niños hay que descartar abusos.

Clínica:

- Prurito en zona púbica y perineal.
- Máculas azuladas (*maculae ceruleae*) de 0.5 a 1 cm en abdomen, glúteos y muslos, por inoculación de sustancia anticoagulante suelen estar presentes cuando el individuo lleva infestado largo tiempo.
- Costras por rascado
- Adenopatías inguinales.
- Irritación ocular y conjuntivitis (cuando hay infestación ciliar)

Diagnóstico:

- Visualización del parásito o liendre.

Tratamiento:

- **Permetrina** al 1% crema, champús y lociones dejar actuar durante la noche
- **Productos a base de siliconas.** El componente activo del pediculicida encapsula totalmente al parásito y bloquea sus espiráculos, de modo que el piojo es incapaz de expulsar el agua que obtiene a partir de la succión de sangre del hospedador y su intestino se colapsa. Las formulaciones incluyen una silicona no volátil activa (dimeticona) que se vehicula en una silicona volátil (ciclometicona), que a su vez se evapora tras su aplicación dejando sólo la silicona activa. El preparado se debe dejar actuar durante 8-12 h (algunos productos de reciente aparición son más inmediatos) y se aconseja repetir la aplicación tras 7 días
- **Piretroides al 0.33%.** Presentan poca acción ovicida y precisan de repetición del tratamiento una semana después de la primera aplicación.
- **Extracción manual de liendres**

BIBLIOGRAFÍA

- Tuddenham S, Ghanem KG. Approach to the patient with genital ulcers. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Dec 07, 2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Albrecht MA. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of genital herpes simplex virus. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Dec 22, 2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Albrecht MA. Treatment of genital herpes simplex virus infection. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Jun 04, 2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Ríos German PP, Loeches Yagües B, Rico Nieto A. Úlceras genitales dolorosas y de larga evolución en paciente con leucemia linfática crónica. Revista Española de Geriatria y Gerontología [revista en Internet] Marzo-Abril 2017 [acceso 28 de marzo de 2021]; 52(2): 103-104. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-ulceras-genitales-dolorosas-larga-evolucion-S0211139X16300993>
- Díaz A, Ruiz-Algueró M, Hernando V. Linfogranuloma venéreo en España, 2005-2015: revisión de la bibliografía. Medicina Clínica [revista en Internet] Noviembre 2018 [acceso 28 de marzo de 2021]; 151(10): 412-417. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-linfogranuloma-venereo-espana-2005-2015-revision-S0025775318304445>
- Seña AC, Cohen MS. Treatment of uncomplicated *Neisseria gonorrhoeae* infections. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; Jan 14, 2021 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>

- Ghanem KG. Clinical manifestations and diagnosis of *Neisseria gonorrhoeae* infection in adults. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Jun 17,2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Hsu K. Clinical manifestations and diagnosis of *Chlamydia trachomatis* infections. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 21,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Hsu K. Treatment of *Chlamydia trachomatis* infection. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 21,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Manual MSD. Versión para profesionales [sede Web]. Kenilworth, NJ, USA: Merck Sharp & Dohme Corp.; jul 2019 [acceso 28 de marzo de 2021]. Morris SR. Granuloma inguinal. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual/granuloma-inguinal>
- Manual MSD. Versión para profesionales [sede Web]. Kenilworth, NJ, USA: Merck Sharp & Dohme Corp.; jul 2019 [acceso 28 de marzo de 2021]. Morris SR. Linfogranuloma venéreo (LGV). Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual/linfogranuloma-ven%C3%A9reo-lgv>
- Hamill M. Lymphogranuloma venereum. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Sep 16,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 28 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España [sede Web]. Madrid, junio 2019 [acceso 30 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia ITS_1995_2017_def.pdf
- HicksCB. Chancroid. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 17,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Lewis , DA Epidemiology, clínica, features, diagnosis and treatment of *H. Ducreyi* , a disappearing pathogens?. Expert Rev antiinfection ther , 2014 , 12:687
- Rosen T. Condylomata acuminata (anogenital warts) in adults: Epidemiology, pathogenesis, clinical, diagnosis and treatment. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Feb 15,2019 [actualizado Feb 2021; acceso 18 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- De Villers EM, Fauquet C, Broker TR , et al. Classification of papillomaviruses virology 2004: 324:17
- Hicks CB, Clement M. Syphilis: Epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations in patients without HIV. [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Nov 05,2020 [actualizado Feb 2021; acceso 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>
- Jimenez Aranda P.-Capítulo 89: Enfermedades de transmisión sexual en Julian Jimenez (ed.y coord.) Manual de protocolos y actuación en urgencias. Toledo, Grupo SANED, pp 825-831
- RowleyJ, Vander Hoorn S, Korenromp E, et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates 2016. Bull World Health Organ 2019
- Goldstein AO, Goldstein BG. Pediculosis pubis and pediculosis ciliaris. . [Internet]. Walthman (MA): UpToDate; Oct 25,2018 [actualizado Feb 2021; acceso 18 de marzo de 2021]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>